ANTONELLA DELLE FAVE
MARTA BASSI

PSICOLOGIA E SALUTE

ESPERIENZE E RISORSE DEI PROTAGONISTI DELLA CURA

Seconda edizione

UTET
UNIVERSITÀ

UTET UNIVERSITÀ

www.utetuniversita.it

Proprietà letteraria riservata
© 2013 De Agostini Scuola SpA – Novara
1ª edizione: luglio 2013
Printed in Italy

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere riprodotta in alcuna forma senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume/fascicolo, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO – Corso di Porta Romana, 108 – 20122 Milano – e-mail: *aidro@iol.it*; *www.aidro.org*

Stampa: Stampatre - Torino

Ristampe:	0 1	2 3	4 5	6 7	8 9
Anno:	2013	2014	2015	2016	2017

e pertanto adattativo. Infatti, la convinzione di possedere risorse personali e capacità di gestione adeguata del rischio o della malattia promuove comunque un migliore adattamento e una più efficace mobilizzazione delle risorse individuali sia nell'ambito della prevenzione che dell'adattamento a una condizione patologica.

La speranza

È abbastanza diffusa la convinzione che alcuni stati interiori o aspetti del funzionamento mentale non siano studiabili empiricamente e siano descrivibili soltanto attraverso un linguaggio non scientifico. Partendo da questo presupposto, si nega a queste dimensioni psicologiche la possibilità di essere analizzate attraverso un approccio scientifico, e di essere utilizzate in modo mirato per promuovere la salute mentale, in particolare laddove esse si rivelino risorse potenziali a disposizione dell'operatore e del paziente. È questo il caso della speranza, termine molto usato nel linguaggio comune, presente quasi quotidianamente nei dialoghi tra medici e pazienti, ma poco studiato nelle sue caratteristiche strutturali e nelle sue conseguenze sul comportamento e sulla qualità della vita.

Lo studioso che si è occupato per primo in modo sistematico della speranza e del suo impatto sulla vita umana è stato Charles Snyder, che innanzitutto ne ha dato una definizione operativa: la speranza è credere che si potrà trovare una via (*pathway*) per realizzare i propri obiettivi e la motivazione (*agency*) per percorrerla (Snyder, Rand, Sigmon, 2002). Alcuni elementi di questa definizione sono degni di nota: innanzitutto la speranza implica degli obiettivi specifici e la determinazione ad agire per conseguirli. Non si tratta pertanto di uno stato puramente emotivo, bensì di un processo *cognitivo*, che prevede l'intervento consapevole dell'individuo sulla realtà. Naturalmente, gli obiettivi devono avere un valore ed un significato per la persona, e devono essere realizzabili, se non direttamente almeno attraverso il conseguimento di tappe ed traguardi intermedi. Inoltre, l'individuo deve avere una rappresentazione mentale del percorso da seguire per realizzare questi obiettivi, e deve ritenere di avere le capacità per affrontarlo. Nella costruzione della speranza entrano pertanto in gioco fattori come la percezione di challenge, il locus of control interno, l'auto-efficacia e l'ottimismo, che possono facilitare l'individuazione di modalità adeguate e realistiche di perseguimento degli obiettivi. Tuttavia questi costrutti, in quanto caratteristiche psicologiche generali, hanno un ruolo di mediazione. La speranza invece è un processo specifico e dinamico, che si realizza in circostanze definite e in riferimento a obiettivi determinati.

Questa dimensione operativa della speranza è stata evidenziata nell'ambito della salute, dove si è evidenziato che elevati livelli di speranza si associano a maggiore ricerca di informazioni mediche, a minore percezione di disturbi connessi ad una patologia rara e a migliore aderenza al trattamento in patologie croniche (Berg e coll., 2007). La speranza inoltre induce l'individuo a focalizzare la propria attenzione su obiettivi da raggiungere, piuttosto che a ripiegarsi

su se stesso e sulla propria condizione patologica (Snyder, Pulvers, 2001). Infine, la speranza promuove la salute psicologica: individui con livelli elevati di speranza mostrano un migliore e più rapido adattamento a condizioni di stress e maggiore flessibilità nell'individuare obiettivi e percorsi alternativi, qualora quelli identificati in precedenza non risultino più adeguati alle circostanze presenti (Michael, 2000).

La speranza al termine della vita. È possibile parlare di speranza nella situazione più critica per pazienti, familiari ed operatori sanitari, ovvero il periodo terminale della malattia, quando per definizione non è possibile alimentare speranze di guarigione, miglioramento delle condizioni fisiche o prolungamento della vita?

Elizabeth Kubler-Ross (1970) ha per prima delineato il percorso psicologico attraverso il quale è possibile giungere all'accettazione della situazione di terminalità, distinguendone varie fasi: lo shock, il rifiuto, la rabbia, la negoziazione, la depressione e l'accettazione. Dopo il primo momento di *shock* e disorientamento di fronte ad una prognosi infausta, il paziente utilizza il *rifiuto* come prima modalità di difesa ed autoprotezione dall'idea di una prospettiva di vita limitata. Successivamente, il rifiuto lascia spazio alla *rabbia*; in queste circostanze, come sottolineato in precedenza, è importante che il paziente abbia la possibilità di esprimere le proprie emozioni, per poterle gestire efficacemente nel percorso complesso verso l'accettazione. La persona in questa fase può diventare esigente, eccessivamente irritabile, aggressiva; tuttavia queste reazioni devono essere espresse e canalizzate, in quanto solo un'adeguata elaborazione emotiva conduce allo stadio successivo, la presa di consapevolezza della condizione di terminalità (*negoziazione*). In questa fase il paziente scende a compromessi con la realtà della propria finitezza: molto spesso si prefigge obiettivi da raggiungere «prima di morire»; stipula in cuor suo patti con la vita, quali poter essere presente alla nascita di un nipote, alla laurea di un figlio, o ritardare la morte in funzione del proprio comportamento e della propria preparazione psicologica. In questa fase, come vedremo successivamente, la speranza gioca un ruolo determinante: vari studi infatti mostrano che il perseguire questo genere di scopi è estremamente importante per favorire non solo una migliore qualità della vita, ma anche un'effettiva sopravvivenza in vista degli scopi stessi.

La successiva fase di *depressione* è da considerarsi fisiologica, ed è estremamente importante in quanto permette al paziente di superare angosce e dinieghi, e di prepararsi al termine della vita. L'ultima fase, quella dell'*accettazione*, è definibile, come riferito da un paziente seguito da Kubler-Ross, «il riposo finale prima del lungo viaggio»: benché sia presente una componente di resa all'ineluttabile, essa si inserisce in una dimensione psicologica di pace e riconciliazione con se stessi e con l'ambiente circostante.

Considerando l'unicità biopsicosociale di ogni individuo e di ogni situazione, le fasi illustrate non compaiono necessariamente in sequenza obbligata. Alcuni

pazienti non le percorrono tutte, fermandosi allo stadio del rifiuto o della rabbia; altri pazienti superano con facilità la tempesta emotiva delle prime fasi per giungere rapidamente all'ultima e stabilizzarvisi per un tempo relativamente lungo. Tuttavia, aver presente questa sequenza permette al professionista della salute di contestualizzare i comportamenti e le reazioni di un paziente nell'ambito del processo di accettazione, e di rispondere pertanto ad esse in modo adeguato. Comprendere la fase in cui si trova il paziente è molto importante anche per definire l'iter terapeutico o palliativo più adeguato: le richieste di trattamento da parte dei pazienti, a volte apparentemente assurde ed irrealistiche, sono fortemente ancorate alla fase psicologica in cui essi si trovano. Come vedremo nel capitolo 4, negoziare con il paziente un trattamento tenendo in considerazione questi aspetti permette al professionista di individuare le modalità più corrette di comunicazione e di condivisione delle decisioni terapeutiche.

Dal punto di vista operativo, uno studio qualitativo condotto in Australia attraverso interviste con pazienti, familiari e specialisti in cure palliative fornisce alcuni suggerimenti in merito alla gestione della relazione con i pazienti terminali, per supportarne e mobilizzarne le risorse (Clayton e coll., 2005).

Innanzitutto, emerge l'importanza di enfatizzare non tanto ciò che non è più possibile, ma ciò che ancora *può* essere fatto. In particolare:

- rassicurare il paziente sulle possibilità di controllo dei sintomi;
- fornirgli supporto emotivo, attenzione empatica (per la definizione di empatia si rimanda al capitolo 4) e il massimo dell'accudimento possibile;
- esplicitare al paziente ed ai suoi familiari le potenzialità del trattamento domiciliare, e la disponibilità di ulteriori risorse con il ricovero in strutture assistenziali, quale ad esempio l'hospice.

In secondo luogo, è fondamentale aiutare il paziente ad identificare gli obiettivi realistici sui quali può ancora mobilizzare le proprie risorse personali: essi possono consistere in attività associate ad esperienze ottimali o semplicemente piacevoli, visite a luoghi desiderati o graditi (laddove sia possibile la mobilità, autonoma o assistita), incontri con persone significative.

Infine è utile discutere con il paziente le modalità ottimali con cui gestire la vita quotidiana in questa fase. Lo studio mostra che sia pazienti che professionisti e familiari concordano nell'identificare gli argomenti di discussione più rilevanti. Vengono citati in particolare:

- la focalizzazione sul presente, senza pianificare eccessivamente o crearsi aspettative su eventi che potrebbero o non potrebbero verificarsi nel futuro;
- la consapevolezza che potrebbero esserci giorni «buoni» e giorni «brutti», senza tuttavia concentrare l'attenzione sulle aspettative negative;
- l'importanza di trarre il massimo vantaggio dai giorni «buoni», in cui il paziente si sente bene e può svolgere le sue attività preferite;

- la conservazione di una routine il più possibile vicina alla normalità;
- la gestione adeguata (sia a livello psicologico che terapeutico e logistico) delle giornate «brutte».

Nella fase terminale della malattia il paziente affronta il delicato processo di adattamento ad una prospettiva di vita limitata, che comporta la necessità di identificare obiettivi e speranze a breve termine. Come specificato in precedenza, le speranze che i pazienti dichiarano di coltivare non sono sempre realistiche. Alcuni pazienti inclusi nello studio sopra citato affermavano di confidare comunque nella possibilità di un miracolo; tuttavia, la maggioranza ha dato priorità alla speranza di ricevere cure adeguate, e di veder riconosciuta e tutelata la propria dignità ed identità personale; alcuni di essi infine hanno menzionato la speranza in una morte serena.

Questi risultati evidenziano come sia possibile coltivare la speranza anche nell'ultima fase della vita; essi da un lato mettono in luce l'atteggiamento realistico dei pazienti, e dall'altro suggeriscono l'importanza di non negare al paziente un margine di speranza irrealistico, laddove esso non comporti richieste di trattamenti inutili e di interventi inopportuni. In questi casi occorre piuttosto prospettare con chiarezza a pazienti e familiari l'inefficacia dell'intervento e le sue possibili conseguenze negative: una comunicazione adeguata di questi aspetti, se effettuata secondo modalità empatiche, non confliggerà necessariamente con l'esigenza del paziente di nutrire speranze nel miracolo, evitandogli al tempo spesso inutili sofferenze.

La resilienza

La resilienza è un termine oggi utilizzato in vari ambiti. Origina dalla fisica, in cui è intesa come la capacità di un corpo di attutire i colpi mediante deformazioni elastiche, tramite le quali assorbe energia che poi restituisce quando riacquista la propria struttura originaria.

La psicologia ha fatto suo questo concetto negli ultimi vent'anni, a partire dalla constatazione che alcuni individui, pur essendo esposti a situazioni di grave disagio, non solo non riportano sintomi di malessere e disadattamento, ma ottengono risultati positivi nella vita personale e sociale. Masten e Reed (2002) definiscono la resilienza come l'insieme dei fenomeni che caratterizzano un adattamento soddisfacente all'ambiente, pur in condizioni di avversità o rischio elevato. Per essere definito resiliente, pertanto, un individuo deve ottenere buoni risultati nei vari ambiti della vita, pur trovandosi esposto a situazioni altamente problematiche (le autrici parlano di «circostanze estenuanti»).

Per studiare la resilienza occorre tenere conto dei diversi elementi che ad essa contribuiscono. Occorre innanzitutto valutare il livello di *adattamento* dell'individuo alle sfide e richieste ambientali, utilizzando preferibilmente indicatori oggettivi quali i risultati scolastici o professionali, la qualità delle relazioni interpersonali, il comportamento prosociale e la salute mentale. I *fattori*